

DANS CE SUJET

AUTRES SUJETS DANS CE CHAPITRE

→ Douleurs pelviennes au début de la grossesse

→ Saignement vaginal en début de grossesse

→ **Nausées et vomissements au début de la grossesse**

→ Œdème des membres inférieurs en fin de grossesse

→ Saignement vaginal en fin de grossesse

→ Fièvres pendant la grossesse

Nausées et vomissements au début de la grossesse



Par **Emily F. Bunce**, MD, Wake Forest School of Medicine;
Robert P. Heine, MD, Wake Forest School of Medicine
Reviewed By **Oluwatosin Goje**, MD, MSCR, Cleveland Clinic, Lerner College of Medicine of Case Western Reserve University

Vérfifié/Révisé juil. 2023 | Modifié avr. 2025

Physiopathologie | Étiologie | Bilan | Traitement | Points clés | Multimédia

Les nausées et les vomissements affectent jusqu'à 80% des femmes enceintes. Ces symptômes sont plus fréquents et plus graves pendant le 1er trimestre. Les nausées et les vomissements de la grossesse sont communément appelées "nausées matinales", mais les nausées et/ou les vomissements peuvent survenir à tout moment de la journée. Les symptômes varient de légers à graves (hyperemesis gravidarum).

L'**hyperemesis gravidarum** consiste en des vomissements incoercibles induits par la grossesse, qui entraînent une déshydratation importante, souvent associée à des troubles hydro-électrolytiques ou à une cétose.

Physiopathologie

La physiopathologie de nausées et des vomissements au début de la grossesse est inconnue, bien que des facteurs métaboliques, endocriniens, digestifs et psychologiques aient été identifiés. Les œstrogènes peuvent y contribuer parce que les taux plasmatiques sont élevés chez les patientes qui présentent des vomissements gravidiques graves (hyperemesis gravidarum).

Étiologie

Les causes les plus fréquentes de nausées et de vomissements non compliqués au début de la grossesse (voir tableau [Certaines causes de nausées et de vomissements en début de grossesse](#)) sont les suivantes

- Les nausées et les vomissements de la grossesse (très fréquents).
- Hyperemesis gravidarum
- [Gastro-entérite](#)

Occasionnellement, les préparations vitaminées prénatales à base de fer sont la cause des nausées. Rarement, vomissements persistants, graves résultant d'une [môle hydatiforme](#).

Les vomissements peuvent également résulter de nombreuses pathologies non obstétricales. Les causes fréquentes d'abdomen aigu (p. ex., appendicite, cholécystite) peuvent survenir pendant la grossesse et être accompagnées de vomissements, mais le trouble principal est généralement la douleur. De même, certains troubles du système nerveux central (p. ex., migraine, hémorragie du système nerveux central, hypertension intracrânienne, méningite) peuvent être accompagnés de vomissements, mais les symptômes neurologiques sont généralement la plainte principale.

Bilan

Le bilan des patientes présentant des nausées et des vomissements en début de grossesse vise à exclure les causes graves ou potentiellement mortelles de nausées et de vomissements. Les nausées et vomissements gravidiques non compliqués et l'hyperemesis gravidarum sont des diagnostics d'exclusion.

TABEAU

[Certaines causes de nausées et de vomissements en début de grossesse](#)

Anamnèse

L'**anamnèse de la maladie actuelle** doit en particulier tenir compte de:

- Date d'accouchement estimée (et si elle est basée sur la dernière période menstruelle ou l'échographie)
- Tous les facteurs de risque de complications obstétricales et tests antérieurs ou complications pendant la grossesse en cours
- L'apparition et de la durée des vomissements
- Des facteurs aggravants et de soulagement
- De la fréquence (intermittente ou permanente)
- Du type (p. ex., sanguinolents, aqueux, bilieux) et de la quantité des vomissements

Les symptômes associés importants comprennent la diarrhée, la constipation et les douleurs abdominales. Lorsque la douleur est présente, la localisation, l'irradiation et la gravité doivent être précisés. L'examineur doit également évaluer les conséquences sociales des symptômes (p. ex., capacité de poursuivre son travail et de s'occuper d'elle-même et de l'enfant).

La **revue des systèmes** doit rechercher les symptômes de causes non obstétricales de nausées et de vomissements, comprenant une fièvre ou des frissons, en particulier si accompagnés de douleurs de l'hypochondre ou de symptômes mictionnels ([infection urinaire](#) ou pyélonéphrite), de symptômes neurologiques tels que céphalées, faiblesse, déficits et confusion ([migraine](#) ou [hémorragie du système nerveux central](#)).

La **recherche des antécédents médicaux** comprend des questions sur les nausées matinales ou les vomissements incoercibles lors de précédentes grossesses. L'anamnèse chirurgicale doit comprendre des questions sur tout antécédent de chirurgie abdominale, qui prédisposerait à une occlusion intestinale mécanique.

Les médicaments qui pourraient y contribuer (p. ex., composés contenant du fer, hormones), de même que la sécurité des médicaments pris pendant la grossesse doivent être analysés.

Examen clinique

L'évaluation des patientes pendant la grossesse doit comprendre une évaluation prénatale systématique de l'état de la mère et du fœtus, dont

- Évaluation des signes vitaux maternels
- Examen abdominal pour la mesure de la hauteur du fond
- Parfois, examen pelvien
- Évaluation du statut fœtal avec auscultation de la fréquence cardiaque fœtale
- Parfois, échographie pelvienne (en fonction des symptômes et de l'âge gestationnel)

L'examen commence par la recherche d'anomalies des constantes vitales, fièvre, tachycardie et pression artérielle anormale (trop basse ou trop élevée).

Un bilan général est effectué à la recherche de signes de toxicité (p. ex., léthargie, confusion, agitation). Un examen clinique complet, don un examen pelvien, est réalisé afin d'éliminer une cause mettant potentiellement en jeu le pronostic vital de nausées et de vomissements (voir tableau [Signes d'examen clinique importants chez une femme enceinte présentant des vomissements](#)).

Signes d'alarme

Les signes suivants sont particulièrement préoccupants:

- Aucun mouvement ou bruits cardiaques fœtaux perçus
- Signes de déshydratation (p. ex., hypotension orthostatique, tachycardie)
- Examen neurologique anormal
- Fièvre
- Vomissements sanglants ou fécaloïdes
- Douleur abdominale
- Symptômes persistants ou qui s'aggravent

TABEAU

[Signes d'examen clinique importants chez une femme enceinte présentant des vomissements](#)

Interprétation des signes

Distinguer les vomissements liés à la grossesse des vomissements dus à d'autres causes est important. Les manifestations cliniques aident (voir tableau [Certaines causes de nausées et de vomissements en début de grossesse](#)).

Les vomissements sont plus susceptibles d'être dus à une grossesse si

- Les symptômes commencent au cours du 1er trimestre.
- Les symptômes persistent ou récidivent sur plusieurs jours ou semaines.
- La douleur abdominale est absente.
- Il n'y a pas de symptômes ou de signes impliquant d'autres systèmes d'organes.

Si les vomissements semblent liés à la grossesse et sont sévères (c'est-à-dire, fréquents, prolongés, accompagnés d'une déshydratation), un [hyperemesis gravidarum](#) et la [môle hydatiforme](#) doivent être évoquées.

Des causes non obstétricales de nausées doivent être suspectées en cas de symptômes

- Commencent après le 1er trimestre
- Sont accompagnés de douleurs abdominales et/ou d'une diarrhée

Une sensibilité abdominale peut suggérer un abdomen aigu. Un méningisme et/ou des anomalies neurologiques suggèrent une cause neurologique.

Examens complémentaires

En cas de vomissements et/ou de signes de déshydratation significatifs un bilan est habituellement nécessaire. Si on suspecte des vomissements graves de la grossesse (hyperemesis gravidarum), les cétones urinaires sont mesurées; si les symptômes sont particulièrement importants ou persistants, un ionogramme sanguin doit être effectué.

Si les bruits du cœur fœtal ne sont pas clairement audibles ou détectables par le doppler fœtal, une échographie pelvienne doit être pratiquée pour évaluer l'état du fœtus et éliminer une môle hydatiforme.

D'autres examens sont effectués si des troubles non obstétricaux sont suspectés à l'examen clinique (voir tableau [Certaines causes de nausées et de vomissements en début de grossesse](#)).

Traitement

Les nausées et vomissements induits par la grossesse sont soulagés chez certaines patientes en buvant ou en mangeant fréquemment (5 ou 6 petits repas/jour) et/ou en ne mangeant que des aliments fades (p. ex., biscuits, régime BRAT [bananes, riz, compote de pommes, toasts secs]). Manger avant de se lever le matin peut être utile.

Si une déshydratation (p. ex., due à un hyperemesis gravidarum) est suspectée, 1 à 2 L de solution physiologique ou de Ringer lactate sont administrés en IV et les troubles hydro-électrolytiques identifiés sont corrigés.

Après la réanimation liquidienne initiale, du dextrose IV peut être ajouté au liquide d'entretien si l'apport oral reste limité. Avant l'administration de dextrose, de la thiamine 100 mg IV doit être administrée pour prévenir une encéphalopathie de Wernicke.

Certains médicaments (voir tableau [Médicaments agissant sur les nausées et les vomissements au début de la grossesse](#)) sont utilisés pour soulager les nausées et les vomissements pendant le 1er trimestre sans signe d'effet indésirable sur le fœtus.

Rarement, la perte de poids se poursuit et les symptômes persistent malgré le traitement. Dans de tels cas, une nutrition entérale par sonde nasogastrique ou nasoduodénale peut être envisagée. Les cathéters centraux insérés en périphérie sont associés à un taux élevé d'infection et de thromboembolie pendant la grossesse et doivent être évités ([1](#), [2](#)).

La vitamine B6 est utilisée en monothérapie; d'autres produits sont ajoutés si les symptômes ne sont pas soulagés. La doxylamine à libération prolongée plus de la pyridoxine peuvent être administrées aux femmes qui ne répondent pas au traitement initial.

Le gingembre (p. ex., gélules de gingembre 250 mg par voie orale 3 ou 4 fois/jour, sucettes de gingembre), l'acupuncture, les bandes contre la cinétose et l'hypnose permettent d'obtenir des résultats, de même que passer des vitamines prénatales aux comprimés à mâcher riches en folates pour les enfants.

Références pour le traitement

- [Holmgren C, M Aagaard-Tillery KM, Silver RM, et al:](#) Hyperemesis in pregnancy: An evaluation of treatment strategies with maternal and neonatal outcomes. *Am J Obstet Gynecol* 198 (1):56.e1–4, 2008. doi: 10.1016/j.ajog.2007.06.004
- [Cape AV, Mogensen KM, Robinson MK, Carusi DA:](#) Peripherally inserted central catheter (PICC) complications during pregnancy. *JPEN J Parenter Enteral Nutr* 38 (5):595–601, 2014. doi: 10.1177/0148607113489994

Points clés

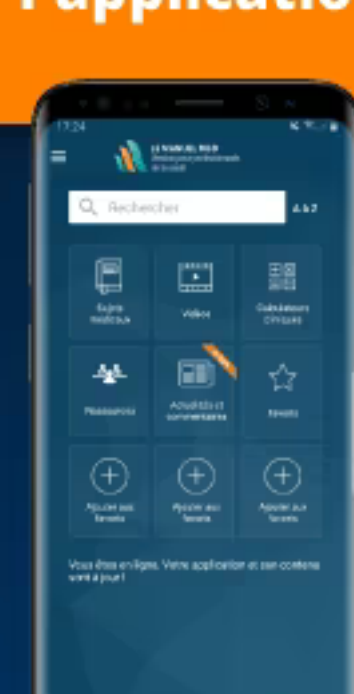
- Les nausées et les vomissements pendant la grossesse sont habituellement auto-limités et répondent à une modification alimentaire.
- L'hyperemesis gravidarum est plus rare mais sévère, aboutissant à une déshydratation, à une cétose et à une perte de poids.
- Envisager des causes non obstétricales de nausées et de vomissements.



TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Take a Quiz!

Téléchargez gratuitement l'application Manuels MSD



Scannez le code pour télécharger dès maintenant

